

Intento suicida

1. Introducción y relevancia clínica

El **suicidio** es una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo. En Chile, según el **Departamento de Epidemiología del MINSAL (2022)**, la tasa de suicidio se estima en **10,3 por 100.000 habitantes**, con un aumento progresivo en adolescentes y adultos mayores.

El **intento suicida (IS)** corresponde a **cualquier conducta autoinfligida con intención de morir**, independientemente del resultado.

Su abordaje inmediato constituye una **urgencia médica y psiquiátrica**, que requiere evaluación integral del **riesgo vital y del riesgo de repetición**.

Relevancia clínica

- Es un motivo frecuente de consulta en **Servicios de Urgencia y APS**.
- Hasta el **50% de los suicidios consumados** tienen un intento previo.
- Un manejo adecuado reduce significativamente la **mortalidad y la reincidencia**.
- Es una **competencia crítica del médico general** evaluada en el **EUNACOM clínico y ECOE**.

□ El principio rector es: **“Toda conducta suicida debe tomarse en serio, sin minimizar ni moralizar.”**

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El comportamiento suicida resulta de una **interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales**.

2.1. Modelo biopsicosocial

1. Factores biológicos:

- Disfunción serotoninérgica (↓ 5-HT en corteza prefrontal y rafe dorsal).

- Alteraciones en eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (hipercortisolismo).
- Heredabilidad parcial (riesgo 5–6 veces mayor en familiares de primer grado).

2. Factores psicológicos:

- Desesperanza, impulsividad, anhedonia, perfeccionismo rígido.
- Trastornos psiquiátricos:
 - Depresión mayor (60–70% de los casos).
 - Trastorno bipolar.
 - Esquizofrenia (especialmente fases iniciales).
 - Trastornos de personalidad (borderline, antisocial).

3. Factores sociales:

- Aislamiento, desempleo, duelo, violencia, bullying, rupturas afectivas.
- Acceso a medios letales (armas, pesticidas, medicamentos).

2.2. Conceptos clave

Concepto	Definición
Ideación suicida	Pensamientos o deseos de morir, con o sin plan.
Plan suicida	Estrategia o método concreto para ejecutar el acto.
Intento suicida	Conducta autoinfligida con intención de morir, aunque no logre el resultado.
Suicidio consumado	Muerte autoinfligida con intención comprobada.

Conducta parasuicida	Acto autolesivo sin intención clara de morir (comunicación de malestar o manipulación afectiva).
-----------------------------	--

☐ En clínica, **toda autolesión debe considerarse potencialmente suicida hasta demostrar lo contrario.**

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas

Los pacientes con riesgo suicida pueden presentar:

- **Síntomas afectivos:** tristeza, desesperanza, culpa, anhedonia.
 - **Cognitivos:** ideas de inutilidad, pesimismo, deseo de desaparecer.
 - **Conductuales:** aislamiento, regalar pertenencias, redactar testamento, búsqueda de métodos letales.
 - **Verbalizaciones directas o indirectas:**
 - Directas: “Me quiero morir”, “no vale la pena seguir.”
 - Indirectas: “Pronto descansaré”, “ya no molestaré más.”
 - **Síntomas físicos:** insomnio, fatiga, pérdida de apetito, agitación.
-

3.2. Factores de riesgo

Tipo	Ejemplos
Psiquiátricos	Depresión, bipolaridad, psicosis, abuso de sustancias, trastornos de personalidad.
Biológicos	Enfermedad crónica dolorosa, discapacidad, antecedentes familiares de suicidio.

Sociales Pérdida de empleo, ruptura sentimental, soledad, acoso, pobreza.

Conductuales Intento previo, planificación detallada, acceso a medios letales.

3.3. Factores protectores

- Red familiar y social sólida.
 - Creencias religiosas o espirituales.
 - Responsabilidades familiares o hijos pequeños.
 - Acceso a atención de salud mental.
 - Rasgos de afrontamiento resiliente.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Claves diferenciales
Depresión mayor	Ideación persistente, culpa, anhedonia.
Trastorno límite de la personalidad	Impulsividad, autolesiones recurrentes sin intención de morir.
Psicosis	Ideas suicidas comandadas por alucinaciones.
Duelo complicado	Ideación vinculada al deseo de reunirse con el fallecido.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación inicial (en urgencia)

1. **Evaluar y estabilizar funciones vitales (ABCDE).**
2. Determinar **método utilizado, letalidad y tiempo transcurrido.**
3. Buscar **signos de intoxicación, trauma o hemorragia.**
4. Controlar glicemia, gases, electrolitos y tóxicos si corresponde.

4.2. Evaluación psiquiátrica

Debe incluir los siguientes componentes:

1. **Motivo del intento:** causas, precipitantes, emociones.
2. **Intencionalidad:** grado de deseo real de morir.
3. **Planificación:** método, acceso, preparación.
4. **Medio utilizado:** letalidad objetiva.
5. **Rescate:** espontáneo o accidental.
6. **Antecedentes psiquiátricos y familiares.**
7. **Apoyo social y red familiar.**

☐ La **evaluación del riesgo suicida** debe hacerse con lenguaje claro, sin juicios:
“¿Ha pensado en hacerse daño?” — “¿Cómo lo haría?” — “¿Ha hecho algún intento?”

4.3. Escalas de apoyo (no sustituyen juicio clínico)

- **Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS).**
 - **SAD PERSONS Scale:** orienta gravedad (sexo, edad, depresión, intentos previos, etc.).
 - **Beck Scale for Suicide Ideation.**
-

4.4. Clasificación del riesgo suicida (MINSAL 2023)

Nivel	Características	Manejo
Alto	Plan definido, acceso a medios letales, intento reciente, psicosis o impulsividad severa.	Hospitalización psiquiátrica inmediata.
Moderado	Ideación persistente sin plan concreto, síntomas depresivos graves, red débil.	Evaluación psiquiátrica urgente, posible ingreso voluntario.
Bajo	Ideación ocasional sin plan, buena red de apoyo, sin intento reciente.	Manejo ambulatorio y seguimiento estrecho.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo debe abordar **dos dimensiones simultáneas**:

- **Urgencia médica inmediata.**
 - **Contención y tratamiento psiquiátrico integral.**
-

5.1. En urgencia médica

1. **Asegurar vía aérea, ventilación y circulación.**

2. **Tratar las complicaciones físicas:** intoxicaciones, heridas, trauma.
 3. **Tiamina y glucosa EV** si hay consumo de alcohol.
 4. **Vigilancia continua** hasta estabilización.
 5. **Retiro de objetos o sustancias peligrosas.**
-

5.2. Contención y ambiente terapéutico

- Lugar tranquilo, sin estímulos violentos ni juicios.
 - Personal empático y no confrontacional.
 - Retirar cinturones, cordones, objetos cortantes o punzantes.
 - Supervisión constante por personal capacitado.
 - Comunicación calmada, tono empático y presencia activa.
-

5.3. Manejo farmacológico

Dirigido a tratar el **trastorno de base**:

Diagnóstico de base	Tratamiento agudo
Depresión mayor	ISRS (sertralina, escitalopram) + psicoterapia.
Trastorno bipolar (fase depresiva)	Estabilizador del ánimo (lamotrigina, valproato).
Esquizofrenia	Antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina).

Abstinencia o ansiedad aguda

Benzodiacepinas de vida corta (lorazepam) solo temporalmente.

Insomnio

Higiene del sueño o trazodona a dosis bajas.

- Evitar **antidepresivos tricíclicos** en pacientes suicidas: alta letalidad en sobredosis.

5.4. Derivación y hospitalización

- **Obligatoria** en riesgo alto o falta de contención familiar.
- **Voluntaria o involuntaria** según Ley N° 21.331 de Derechos en Salud Mental (Chile).
- En caso de riesgo vital inminente → hospitalización inmediata aunque el paciente se niegue.
- Requiere **evaluación psiquiátrica en las primeras 24 h.**

5.5. Manejo ambulatorio (riesgo bajo o moderado)

- Seguimiento en APS o salud mental cada 48–72 h.
- Derivación a psicoterapia cognitivo-conductual o interpersonal.
- Involucrar familia o red de apoyo en la vigilancia.
- Plan de seguridad por escrito:
 - Números de emergencia.
 - Estrategias de distracción y afrontamiento.
 - Restricción de medios letales (medicamentos, armas).

5.6. Postvención (prevención secundaria)

- Evaluar y tratar **trastorno de base y consumo de sustancias**.
 - Incluir intervención familiar.
 - Derivar a programa de prevención del suicidio (APS o COSAM).
 - Seguimiento continuo por al menos 6 meses.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Lesiones físicas graves, anoxia cerebral, insuficiencia renal, trauma.
 - Reincidencia del intento suicida (20–40%).
 - Estigmatización familiar o social.
 - Síndrome de estrés postraumático postintento.
 - Muerte por error terapéutico o falta de seguimiento.
-

Pronóstico

- Mejor con **detección precoz y tratamiento integral**.
 - El riesgo de repetición es máximo durante los **primeros 3 meses** posteriores al intento.
 - Factores de mal pronóstico:
 - Trastorno afectivo bipolar o esquizofrenia.
 - Intento violento o altamente letal.
 - Ausencia de red social o apoyo familiar.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Todo intento suicida requiere **evaluación médica y psiquiátrica completa**.
 2. La **intención suicida no se evalúa con juicios morales**, sino con preguntas claras.
 3. La **tiamina debe administrarse antes de glucosa** en pacientes alcohólicos.
 4. Los **antidepresivos ISRS** son los más seguros en pacientes suicidas.
 5. La **hospitalización involuntaria** se justifica si hay **riesgo vital inminente**.
 6. Todo paciente dado de alta debe tener **plan de seguridad** y seguimiento documentado.
 7. Un **intento previo** es el predictor más importante de suicidio consumado.
-



Errores comunes

- Minimizar la ideación (“solo lo dijo para llamar la atención”).
 - Dar el alta sin evaluación psiquiátrica.
 - Prescribir grandes cantidades de fármacos potencialmente letales.
 - No informar a la familia o red de apoyo.
 - No registrar riesgo ni plan de seguimiento en ficha clínica.
 - Usar benzodiacepinas crónicamente sin tratar el cuadro de base.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **intento suicida** es una **urgencia médica y psiquiátrica**, no un problema exclusivamente psicológico.

2. La evaluación inicial incluye **estabilización física y valoración estructurada del riesgo suicida**.
3. La **hospitalización** es obligatoria ante riesgo alto o falta de red de apoyo.
4. El tratamiento debe abordar la **causa de base** (depresión, psicosis, bipolaridad, sustancias).
5. Los **ISRS son los antidepresivos de elección** por su seguridad en sobredosis.
6. Todo paciente requiere **plan de seguridad, seguimiento y participación familiar**.
7. La **prevención del suicidio** es responsabilidad transversal de todo el equipo de salud.